



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
BANTUAN HIDUP DASAR (BHD)
TAHUN 2026

**TOR (TERM OF REFERENCE)
PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, termasuk pelayanan kegawatdaruratan yang menuntut respons cepat, tepat, dan terkoordinasi. Salah satu kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan segera adalah henti jantung dan henti napas. Keberhasilan penanganan kasus tersebut sangat dipengaruhi oleh kecepatan pengenalan kondisi pasien, pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang sesuai standar, serta koordinasi tim dalam memberikan pertolongan sebelum dilakukan tindakan resusitasi lanjutan.

Seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit, baik dokter, perawat, bidan, maupun tenaga kesehatan lainnya, memiliki peran penting dalam memberikan pertolongan awal terhadap pasien yang mengalami kegawatdaruratan. Selain itu, tenaga penunjang yang berpotensi menjadi penolong pertama di lingkungan rumah sakit juga perlu memiliki pemahaman dasar mengenai tata laksana kegawatdaruratan. Oleh karena itu, setiap petugas harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan Bantuan Hidup Dasar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pedoman klinis, dan standar pelayanan yang berlaku.

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar merupakan salah satu upaya strategis rumah sakit untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mengenali henti jantung, melakukan penilaian awal pasien, mengaktifkan sistem respons kegawatdaruratan, melaksanakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) yang berkualitas, menggunakan Automated External Defibrillator (AED) apabila tersedia, serta melakukan penanganan awal pada kasus sumbatan jalan napas. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu mempercepat waktu respons, meningkatkan keselamatan pasien (patient safety), menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat keterlambatan penanganan, serta mendukung mutu pelayanan rumah sakit.

Di samping itu, penyelenggaraan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya rumah sakit dalam memenuhi standar mutu pelayanan, meningkatkan budaya keselamatan pasien, serta memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kegawatdaruratan. Kompetensi BHD yang baik juga menjadi salah satu indikator kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi kondisi kegawatdaruratan baik di dalam area pelayanan maupun pada situasi bencana.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi tenaga kesehatan di rumah sakit sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesiapsiagaan petugas dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, tepat, aman, dan sesuai standar, sehingga dapat mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
- Pelatihan Bantuan Hidup Dasar di RS diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tenaga Kesehatan di rumah sakit dalam melakukan penanganan awal pada pasien yang mengalami kondisi kegawatdaruratan, khususnya henti jantung dan henti nafas.
2. Tujuan
- a. Tujuan Umum

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengaplikasikan apa yang didapat dari pelatihan bantuan hidup dasar ini dalam kegiatan pelayanan di RS Prima Husada Malang.

b. Tujuan Khusus

a) Mengenali tanda dan gejala henti jantung, henti nafas, serta kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan segera

b) Melakukan penilaian awal terhadap korban secara sistematis dan aman

c) Mengaktifkan sistem respons kegawatdaruratan atau code blue sesuai prosedur rumah sakit

d) Melaksanakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) dengan teknik yang benar dan berkualitas

e) Melakukkann penanganan awal pada kasus sumbatan jalan nafas (tersedak) pada orang dewasa sesuai pedoman

f) Menerapkan prinsip keselamatan pasien dan keselamatan petugas selama pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 SUSUNAN PANITIA

NO	SUSUNAN PANITIA	NAMA	TUGAS
1	Ketua Panitia	Debi Firmanasia, S.Kep.,Ns	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara. Hasil akhir : LPJ
2	Sekretaris	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen. Hasil akhir : 1) notulen 2) LPJ
3	Moderator	Novia Ainur P, S.KM	bertanggung jawab sebagai moderator dan mengaktifkan tanya jawab peserta. Hasil akhir: ringkasan persesi dan tanya jawab
4	Absensi	Novia Ainur P, S.KM	bertanggung jawab terhadap kelengkapan absensi dan menyiapkan serta membagikan kuesioner pelathan. Hasil akhir: rekap absensi dan kuesioner pelatihan
5	Sie Dokumentasi	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	bertanggung jawab sebagai fotografer. Hasil akhir: foto di LPJ
6	Sie Perlengkapan	Bagas Surya, AMd.Kep	bertanggung jawab terhadap kelengkapan peralatan, peminjaman, dan pengembalian

			alat. Mengambilkan alat-alat yang belum tersedia saat acara
7	Sie Penunjang	Sekretaris RSPH (MONEV : SDM, PKRSRM)	bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan
8	Sie Pretest dan Posttest	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	bertanggung jawab terhadap pembagian, pelaksanaan, penilaian pre-post test. Hasil akhir : rekap pre-post test

2.2 RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2026 Dengan Rincian Sebagai Berikut:

- a. Jadwal Pelatihan BHD Klinis

Tanggal : 05 Agustus 2026

Waktu : 08.00 s/d 10.00 WIB

Tempat : Hall Sakura Lantai 3 RS Prima Husada Sukorejo
- b. Jadwal Pelatihan BHD Non Klinis

Tanggal : 12 Agustus 2026

Waktu : 08.00 s/d 10.00 WIB

Tempat : Hall Sakura Lantai 3 RS Prima Husada Sukorejo

2.3 RENCANA RAPAT PANITIA PENYELENGGARAAN

JUDUL MATERI	SASARAN	NARASUMBER	METODE	PERLENGKAPAN	FREKUENSI PELAKSANAAN	DASAR MATERI	OUTPUT TRAINING	TARGET TRAINING JANGKA PANJANG
Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	1. Perawat 2. Bidan	dr. Robby, Sp.An	1. Pre-Post Test 2. Presentasi 3. Diskusi 4. Tanya Jawab	a. LCD b. Laptop c. Sound system d. Alat Tulis	1x / tahun	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 3 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VII/I/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit	1. Tenaga kesehatan mengali tanda dan gejala henti jantung, henti nafas serta kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan Tindakan segera 2. Mampu melakukan penilaian awal terhadap korban secara sistematis dan aman 3. Adanya (SOP) BHD 4. Mampu mengaktifkan system respons code blue sesuai prosedur 5. Mampu melakukan Resusitasi Jantung Paru dengan Teknik yang benar dan berkualitas	1. Seluruh unit yang melakukan BHD mengikuti standar yang sama (SOP, protokol, checklist) 2. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengaplikasikan apa yang didapat dari pelatihan BHD ini dalam kegiatan pelayanan 3. Seluruh staf mampu mengaktifkan system respons code blue

Outline Training

NO	OUTLINE	ISI PPT	PJ
1	Barcode absensi	QR code absensi	MC
2	Pre test	QR code pre test dengan waktu (estimasi 30 detik / pertanyaan)	MC
3	Susunan acara	Tabel rundown acara training	MC
4	Judul	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	Narsum
5	Latar Belakang	Pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar di RS merupakan salah satu upaya strategis rumah sakit untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mengenali henti jantung, melakukan penilaian awal pasien, mengaktifkan sistem respons kegawatdaruratan, melaksanakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) yang berkualitas	Narsum
6	Target	1. Seluruh staf memahami konsep BHD 2. Seluruh staf memahami henti jantung dan henti nafas 3. Seluruh staf memahami Langkah-langkah pengaktifan code blue 4. Seluruh staf memahami Teknik BHD yang benar dan Teknik sirkulasi 5. Seluruh staf memahami tanda tanda BHD di hentikan	Narsum
7	Konsep dasar BHD	1. Definisi BHD dan tujuannya 2. Tanda-tanda henti jantung dan henti nafas 3. Langkah langkah pengkatifan code blue 4. Teknik BHD dan sirkulasi pada pasien dewasa, anak, bayi 5. Tanda BHD dihentikan	Narsum
8	Praktik	Praktik melakukan BHD dilanjutkan praktikum satu persatu oleh staf	Narsum
9	Kesimpulan	Penekanan pada hal-hal yang harus dilakukan setelah ini	MC
10	Post Test	QR code post test dengan waktu (estimasi 30 detik / pertanyaan)	MC

Rapat : Pre Training : Materi/ Bahasan Alur Persiapan dan Pelaksanaan Training

NO	LANGKAH	PJ	YANG TERLIBAT
Pre Training			
1	Mendiskusikan materi yang akan diberikan untuk training (materi berdasarkan outline training)	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	Komite Keperawatan & Kebidanan Hasil materi di CC ke SDM
2	Pembuatan soal pre/post test & kunci jawaban	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	
3	Pembuatan PPT berdasarkan materi yang sudah didiskusikan	dr. Robby, Sp. An	Narasumber
4	Pengumpulan PPT materi maksimal H-7 acara	dr. Robby, Sp. An	Narasumber
5	Menentukan moderator training	Novia Ainur P, S.KM	PJ Bab PAB
6	Menyusun panitia (MC merangkap dokumentasi, IT sebagai operator)	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	PJ Bab PAB
7	Membuat / membahas Form Evaluasi penyelenggara untuk narasumber	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	PJ Bab PAB
8	Media apa saja yang perlu disiapkan agar diklat berjalan sesuai tujuan dan harapan	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	PJ Bab PAB
9	Penyusunan slide host (PPT yang ditampilkan sejak awal mulai dari absensi, pre test, rundown, ppt materi, post test dijadikan 1 kesatuan)	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	Panitia

2.4 SASARAN ATAU PESERTA

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Perawat	191
2	Bidan	24
3	Non Klinis	246
TOTAL		461

2.5 SUSUNAN ACARA LENGKAP

Rundown kegiatan

JAM	DURASI	MATERI	PEMATERI
Gelombang I			
08.00-08.15 WIB	15 menit	Pretest	Tim
08.15-09.45 WIB	50 menit	1. Definisi BHD dan tujuannya 2. Tanda-tanda henti jantung dan henti nafas 3. Langkah langkah pengaktifan code blue 4. Teknik BHD dan sirkulasi pada pasien dewasa, anak, bayi 5. Tanda BHD dihentikan Kesimpulan	dr. Robby. An-Ti
	30 menit	Praktik BHD	Tim
	10 menit	Tanya Jawab	Tim
09.45-10.00 WIB	15 menit	Post test	Tim

2.6 NARASUMBER

1. dr. Robby, Sp.An-Ti

2.7 MEDIA

1. LCD
2. Laptop
3. Sound system

2.8 METODE

1. Pre-Post Test
2. Presentasi
3. Diskusi
4. Tanya Jawab

2.9 KEBUTUHAN ANGGARAN

NO.	RINCIAN KEBUTUHAN	JUMLAH	SATUAN (RP)	HARGA (RP)	SUMBER DANA
1	Nasi pemateri	1 kardus	Rp 20.000	Rp 20.000	Dapur RSPHS
2	Aqua botol	1 botol	Rp 5.000	Rp 5.000	Dapur RSPHS
3	Aqua gelas	4 dus	Rp 25.000	Rp 100.000	Dapur RSPHS
4	Sertifikat	174	Rp 0	Rp 0	Internal Cetak Soft copy oleh SDM
5	Fee Pemateri	2x	Rp. 250.000	Rp. 500.000	PT DPM
Total				Rp 625.000	
Yang diajukan kepada PT Disa Prima Medika				Rp 625.000	

III. MONITORING – EVALUASI

3.1 MONITORING

NO	BAHASAN DAN KEGIATAN	PJ	YANG TERLIBAT/ YANG MASUK PANITIA
1	Memastikan training berjalan sesuai TOR dan rundown	SDM	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns
2	Mencatat evaluasi yang ditemukan selama training berjalan	SDM	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns
3	Memimpin evaluasi setelah training selesai	SDM	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns
4	Mengirimkan link g-form evaluasi yang diisi oleh narasumber	SDM	Narasumber
5	Menyiapkan kredensial apabila materi training ada sesi praktek / role play	SDM	Ketua Komite terkait

3.2 EVALUASI

EVALUASI (POST TRAINING) JANGKA PENDEK			
1	Merekapitulasi hasil nilai pre test dan post test	Novia Ainur P, S.KM	Panitia
2	Melakukan evaluasi hasil penilaian baik untuk penyelenggara maupun untuk narasumber dan pengamatan perilaku peserta saat diklat (serius, mengantuk, antusias)	Novia Ainur P, S.KM	Panitia
3	Menerbitkan sertifikat	SDM	SDM
4	Evaluasi kinerja panitia	SDM	SDM

EVALUASI (POST TRAINING) JANGKA PANJANG			
1	Melakukan supervisi atau observasi kepatuhan peserta diklat terhadap regulasi dan materi-materi dalam diklat yang sudah diikuti	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	SDM dan PJ Bab PAP
2	Hasil supervisi dibahas di rapat koordinasi	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	PJ Bab PAP
3	Membuat RTL-TL-Evaluasi secara berkala	Debi Firmanasia, S.Kep., Ns	PJ Bab PAP

IV. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Untuk mempertahankan nilai Akreditasi Rumah Sakit yang Paripurna. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan acara ini.

Malang, 23 Juli 2026

Mengetahui,
SDM RS Prima Husada

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Novia Ainur Pratiwi, S.KM

Ketua Panitia,

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Debi Firmanasia, S.Kep., Ns

Disetujui oleh,
Direktur RS Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep